Virus respiratorio sincitial

¿Qué debes saber?

Farmacéuticos
Consejo General de Colegios Farmacéuticos

¿Qué se sabe?

Recientemente se ha aprobado un nuevo fármaco llamado **nirsevimab** para proteger a los menores de 1 año en su primera exposición a este virus. Con este fármaco se inyectan los anticuerpos contra el virus respiratorio sincitial (VRS) para bloquear al virus, pudiendo disminuir en alrededor de un 75% las infecciones más graves.

La mayoría de las comunidades autónomas han comenzado una **campaña de inmunización** con este nuevo fármaco, principalmente destinada a **niños menores de 6 meses y con preferencia de aquellos con mayor riesgo**, entre los que se incluyen los lactantes prematuros y niños con enfermedades crónicas pulmonares, cardiológicas o inmunológicas.

Para el año que viene se espera que se comercialice en España la primera vacuna destinada al VRS de ADN recombinante que ofrecerá una inmunización pasiva a niños lactantes desde los 6 meses tras la inmunización materna durante el embarazo y protección activa a los mayores de 60 años como prevención frente a este virus.

¿Qué es el virus respiratorio sincitial (VRS)?

El **virus respiratorio sincitial (VRS)** es un virus estacional que se presenta fundamentalmente durante los meses de octubre a marzo (lo que se conoce como temporada de transmisión de VRS). Produce infecciones respiratorias, sobre todo en niños menores de 2 años. Es **el principal causante de bronquiolitis**, una infección del aparato respiratorio del niño.

Las infecciones por VRS provocan numerosas consultas médicas en los centros de Atención Primaria y los servicios de urgencias. Además, son la primera causa de hospitalización en menores de 1 año durante la temporada en la que circula este virus.

Este virus tiene un mayor riesgo en lactantes prematuros, niños con enfermedades crónicas pulmonares, cardiológicas o algún tipo de déficit del sistema inmune. Sus principales síntomas son moqueo, apetito reducido, irritabilidad, tos, estornudos, fiebre, dificultad para respirar y sibilancias.

Consideraciones desde la Farmacia:

- El VRS es un virus estacional que afecta sobre todo a niños recién nacidos, con un mayor riesgo en aquellos que son prematuros, y en aquellos que tienen algún tipo de enfermedad pulmonar, cardiaca o inmunitaria.
- El diagnostico se basa principalmente en reconocer los síntomas clínicos más característicos como son el moqueo, la falta de apetito, la irritabilidad, tos, estornudos, fiebre, dificultad respiratoria y sibilancias. En los casos más grave requiere hospitalización.
- No existe un fármaco específico que combata el VRS por lo que el tratamiento será sintomático enfocado a controlar la fiebre y mantener la hidratación.
- Niservimab, fármaco con el que se ha empezado la campaña de inmunización este año, es un anticuerpo monoclonal destinado a proteger a los menores y disminuir el riesgo de complicaciones y hospitalización.

Más información y entrevistas:
914312560 / comunicacion@redfarma.org / www.farmaceuticos.com
dUsvR3l0Ty9hbm9DUHdSQ3d3azJmRUpmTWliQ0JyL2pYSnpvaWlQTDhUd3hseXBKbGJvNVZ3PT01